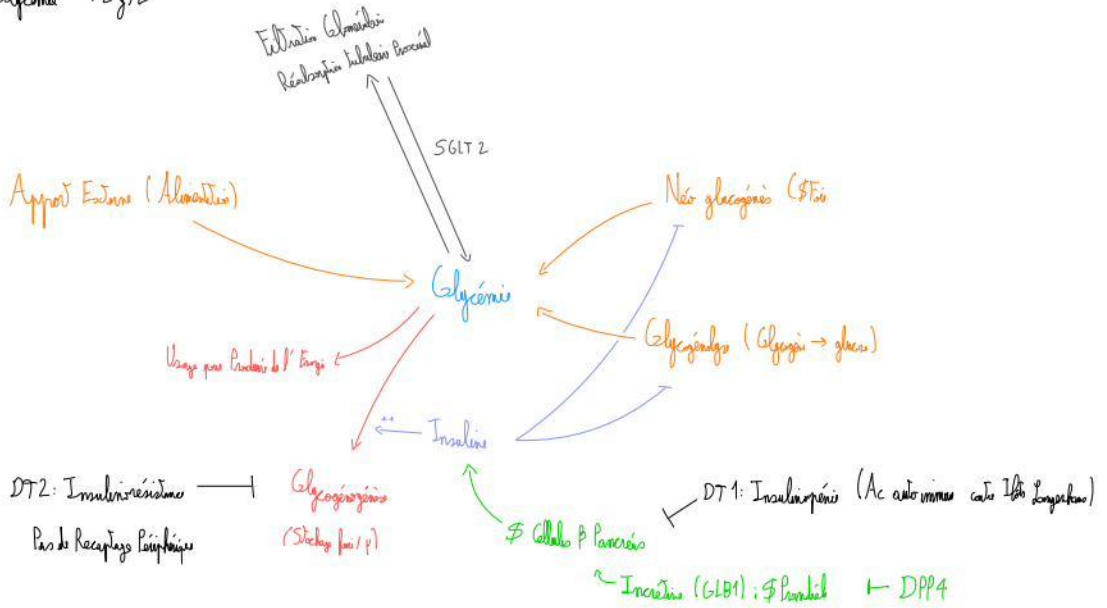


Médicaments du diabète

Glycémie à jeun $> 1,26$ g/L à 2 reprises
 Glycémie > 2 g/L



Insulinorésistance

Insuline (DT1)

↑ capteurs de glucose ; ↑ glycogénosynthèse ; ↓ glycogénolyse

ⓔI Hypoglycémie

Les **BIGUANIDES** → pour combler l'insulinorésistance DT2

Metformine : ↓ néoglucosynthèse

↓ glycogénolyse

↑ capteurs glucose conjoints

Pas d'impact sur l'insuline = Pas de risque d'hypoglycémie

ⓔI Trouble digestif + diarrhées (du jeûne)

ⓔI Gène Insuffisance rénale → Metformine éliminée par les reins → ↑ risque d'acidose lactique

Insuline Rapide & Basale
 NOVORAPID & ABASAGLAR

Hypoglycémisants	Hyperglycémisants
- β-bloquants - IEC - Sulfamides hypoglycémisants - Sulfamides antibactériens - Alcool	- β-mimétiques - Corticoïdes - Tacrolimus

Insulinorésistance

SULFAMIDES Hypoglycémisants (f+)

ⓔI IR

Ce médicament

ou GLINIDES

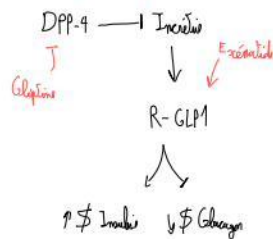
↓ β-Pancréas

ⓔI Hypoglycémie

I⁺ comme K⁺

↓ sécrétion → moins de Ca²⁺ → ↓ [Ca²⁺] cellulaire → Excitation insulin

Insulinorésistance DT2



I⁺ SGLT2 (gliflozine) DT2

Tubule Proximal SGLT2 →
 ⓔI glycémie (inférieure) ; Hypotension
 MAIS
 ↓ Risque Cardio Rénal "PROTECT"